

14 - Les lombalgies - Pr. El Bouchti

Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule les lombalgies. Les objectifs, c'est qu'il faut savoir examiner un rachis lombaire douloureux, connaître les éléments orientant vers une lombalgie symptomatique, connaître les différentes étiologies de lombalgie commune et leur présentation clinique et puis à la fin connaître les grandes lignes de prise en charge des lombalgies communes. Voici le plan qu'on va suivre, après un rappel anatomique et épidémiologique, on va voir le diagnostic positif, différentiel et étiologique des lombalgies et puis les grandes lignes thérapeutiques.

Alors en définition, la lombalgie est définie comme étant une douleur de la région lombaire qui s'étale entre la douzième cote et le pli fessier. Elle peut éradiquer dans les fesses ou à la face postérieure des cuisses mais sans dépasser les genoux. Au-delà des genoux, on parlera de radiculalgie.

La lombalgie est la plus fréquente des manifestations osteoarticulaires et il faut savoir qu'elle n'est qu'un symptôme qui cache une maladie sous-jacente. Concernant la classification des lombalgies, on peut les classer selon leur durée d'évolution et selon les causes. Concernant la durée d'évolution, nous avons la lombalgie aiguë qui évolue au moins d'un mois.

La lombalgie sévère entre un mois et trois mois et la lombalgie chronique évolue au-delà de trois mois. Alors la lombalgie aiguë, elle est le plus souvent commune et guérit spontanément mais peut récidiver. La lombalgie chronique, elle, elle pose de sérieux problèmes de pronostic et de traitement.

La classification selon les causes, on distingue la lombalgie symptomatique ou spécifique qui est inférieure de moins 1% et la lombalgie commune ou non spécifique. Alors les lombalgies symptomatiques, bien que rares, elles sont potentiellement graves et il faut y penser systématiquement. Les lombalgies communes représentent plus de 90%.

C'est essentiellement des lombalgies dégénératives ou des lésions dégénératives des structures anatomiques du rachis. Le rachis lombaire est composé de cinq vertèbres mobiles. La colonne vertébrale est divisée en trois parties anatomiques, une antérieure c'est la colonne discosomatique, moyenne c'est le canal rachidien et postérieure correspondant à l'arc postérieur.

Le corps vertébral lombaire est plus volumineux en comparaison au corps vertébro-cervico-thoracique et prend un aspect réuniforme. L'articulation intervertébrale se compose du disque intervertébral qui est une articulation intercorporeale et des deux articulations interapophysaires postérieures. A la face postérieure du corps vertébral se situe l'espace épidual antérieur qui est situé en avant du sac dural où se trouve le ligament longitudinal.

En arrière se situe le sac dural qui contient au niveau lombaire les racines. Le sac terminal de la moelle épinière se situe le plus souvent au niveau de L1. Le sac dural est limité en arrière par

les lames en postérolatéral et l'épineuse en postérieur.

Voici les différents constituants d'une vertèbre type. Sur le plan épidémiologique, 80% de la population aura dans sa vie une lombalgie. Elle touche essentiellement l'adulte jeune avec un maximum de survenue vers l'âge de 40 ans et un deuxième pic qui est retrouvé chez la femme vers 60 ans qui est l'âge de la ménopause.

La lombalgie est responsable de 7% des arrêts de travail et de 13% des invalidités. Alors concernant le diagnostic positif, l'interrogatoire occupe une place primordiale. Il faut avoir des renseignements concernant l'âge, la profession et les activités physiques et sportives du patient qui peuvent nous orienter vers un facteur déclenchant.

Les antécédents rachidiens tels qu'un lumbago, c'est une lombalgie aiguë, une lombosciatique, une chirurgie de rachis lombaire ou des antécédents néoplasiques, la date et le moment des débuts, est-ce que c'est une lombalgie d'installation brutale ou progressive et puis les circonstances d'apparition, est-ce que c'est une douleur qui est apparue après un soulèvement de poids, après un effort inhabituel, de soulèvement, un faux mouvement, un entrainement en voiture et parfois on ne retrouve pas de facteur déclenchant. Le siège de la douleur, est-ce que c'est une douleur diffuse ou localisée à la partie inférieure ou à la partie haute ? Il faut décrire l'irradiation de la douleur vers la cruralgie qui est la fesse et puis on a dit, au-delà du genou, on parlera de radiculalgie ou de lomboradiculalgie, il faut voir l'intensité de la douleur en se basant sur l'échelle visuelle analogique et aussi par la quantité d'antalgique consommée. L'horaire de la douleur, est-elle mécanique, aggravée par l'effort, calmée par le repos ou bien il s'agit de douleurs inflammatoires qui réveillent le malade la nuit et s'accompagnant d'un réveil matinal prolongé ? L'évolution de la douleur, est-ce qu'elle est intermittente ou bien c'est une douleur d'aggravation progressive ? Le mode de soulagement, une position antalgique, par exemple une position anteflexion qui peut nous orienter vers certaines étiologies, comme on va voir tout à l'heure.

Traitement à l'INS, le retentissement de cette douleur, le retentissement fonctionnel et profond. À l'examen physique du rachis, à l'inspection on va chercher la présence de troubles statiques dans le plan sagittal, on va chercher l'hyperlordose lombaire ou bien une perte de la lordose lombaire et l'exagération de la cyphose dorsale par la mesure de la distance C-7 toise. Sur le plan frontal, à la recherche, une scoliose.

On cherche aussi la présence d'une attitude antalgique ou l'attitude que prend le malade pour baisser sa douleur, que ce soit une inflexion latérale, rectitude ou torsion et on évalue la tonicité musculaire. En cas de scoliose, l'examineur doit déterminer la localisation de la courbure et le côté de la convexité. Sur cette image, vous voyez une scoliose lombaire, une scoliose thoracolombaire, une scoliose thoracolombaire à double courbure.

À la palpation, on va chercher une contracture dans la musculature paravertébrale, mettre en évidence des points douloureux, épineux, articulaire postérieur ou paravertébrale, un éventuel

signe de la sonnette et puis à la mobilité du rachis, dans les différents secteurs, en extension, en latéroflexion, flexion antérieure, on va calculer l'indice de Schubert et la distance d'un sol pour mettre en évidence une éventuelle raideur lombaire. Alors l'examen du patient en antéflexion vise à mettre en évidence une gibbosité qui témoigne de la présence d'une scoliose. On fera un examen clinique complet, examen de rachis cervical et dorsal, un examen neurologique, examen des autres articulations, notamment des hanches et des sacroiliacs et bien sûr un examen somatique complet.

Concernant les examens complémentaires, il faut savoir qu'il n'y a pas d'examen systématique. En matière d'imagerie, la radiographie standard, rachis lombaire, phase et profil permet l'étude de la statique rachidienne, analyser les vertèbres, les disques et les parties molles. Ils sont recommandés uniquement dans les cas suivants.

En cas de suspicion de lombalgie secondaire ou symptomatique, et pour cela on va chercher ce qu'on appelle les red flags ou les drapeaux rouges. En cas de lombalgie chronique, avant un geste infiltratif ou avant une chirurgie, en cas de signe de gravité neurologique, dans un deuxième temps, c'est un scalaire ou un IRM qui peuvent être réalisés. Si ils sont réalisés, c'est justifiant et jamais en première intention.

Le bilan biologique n'est pas systématique non plus, il permet d'éliminer une cause de secondaire et les nécessaires en cas de persistance des symptômes ou de présence de red flags. On fera appel dans un premier temps à la numération en formule sanguine, la VS, la CRP et l'EPP. Le reste du bilan c'est en fonction de l'orientation étiologique.

Concernant le diagnostic différentiel, il faut éliminer les causes non vertébrales de lombalgie, c'est-à-dire que le malade vient consulter pour des douleurs lombaires et l'étiologie est non vertébrale et dans ce cas, sur ce tableau, on voit des exemples d'étiologie de lombalgie non vertébrale, notamment les douleurs de l'appareil digestif. L'ombalgie haute peut être en rapport avec un ulcère de l'estomac, avec une pancréatite. L'ombalgie basse en rapport avec une colite, une diverticulose ou un cancer du côlon.

La région rétropéritonelle, une colique néphrétique, une fibrose et une tumeur rétropéritonelle, un anhydridisme de la haute abdominale. Les étiologies de la région pelvienne, des douleurs menstruelles, l'endométriose, la grossesse et les tumeurs éthériques et puis les autres éléments de l'appareil ostéoarticulaire, notamment la sacroilite, les fractures et les tumeurs sacrées et l'échographie. Il faut savoir que les lombalgies de causes non vertébrales, dans ces situations, l'examen de rachis lombaire est tout à fait normal, on ne réveille pas de douleurs, il n'y a pas de raideur à l'examen clinique.

Concernant le diagnostic étiologique, la question qu'il faut se poser, est-ce que la douleur provient de rachis ? Quand c'est non, l'examen de rachis est tout à fait normal, il s'agit peut-être de diagnostic différentiel, ce qu'on appelle les fausses lombalgies. Est-ce que la douleur

provient de rachisse ? C'est la réponse oui, donc c'est une vraie lombalgie. Maintenant, le challenge qui reste, est-ce que c'est une lombalgie commune ou une lombalgie symptomatique ? Il faut chercher les signes d'alerte rouge.

Sur ce tableau, nous avons listé quelques-uns, quelques signes, notamment un sujet âgé au-delà de 55 ans, l'antécédent de myoplasie, l'antécédent de perte de poids inexplicée, prise de médicaments immunosuppresseurs, une infection concomitante, la présence d'une fièvre, un traumatisme, une ostéoporose, et puis quand on a des signes neurologiques à l'examen physique. Alors les principales étiologies en matière de lombalgie, les lombalgies symptomatiques incitent les causes traumatiques, les causes infectieuses, les causes malignes et les causes rhumatismales. Concernant les lombalgies communes, c'est une atteinte dégénérative des structures constituant le rachisse lombaire, comme une hernie discale, comme une arthrose, comme une pendule d'esthésis et un canal lombaire rétréci.

On commence par les lombalgies symptomatiques, qui sont certes moins fréquentes mais sont plus dangereuses et se caractérisent le plus souvent par un début insidieux avec une évolution progressivement croissante, une douleur qui est de rythme inflammatoire insomnante, le caractère rebelle au traitement symptomatique et l'intensité de la douleur, les localisations multiples atypiques, le contexte et les antécédents, tumoraux et infections notamment. Dans ce cas de figure, le bilan radiologique et l'IRM seront recommandés, associés à un bilan biologique. Ça commence par les infections.

Les infections disco-vertébrales, que ce soit une spondylite, une spondylodécide ou une épидurite. Les germes qu'on peut retrouver, c'est le staphylococque, c'est une infection à la germe d'un eau, la tuberculose ou la brucellose. L'atteinte ou la localisation est souvent hématogène mais peut aussi être par inoculation directe, par une chirurgie ou infiltration rachidienne.

Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique et se manifeste cliniquement par une douleur aiguë, raideur et fièvre et sur le plan biologique, un syndrome inflammatoire important. Concernant la tuberculose, la lombalgie est subaiguë aux chroniques d'installation insidieuse. On peut avoir des signes généraux à ce type d'anorexie, d'amégrissement, présence de notions de comptage tuberculeux qu'il faut absolument chercher et puis il faut savoir que l'inflammation est peu marquée voire absente, ce qui n'élimine pas le diagnostic de tuberculose.

Un bilan physiologique est demandé, notamment un IDR à la tuberculine, l'examen des crachats à la recherche de BK et la radiographie de thorax à la recherche d'une infection pulmonaire concomitante. Dans l'infection vertébrale, il faut mettre en évidence le germe par l'hémoculture, culture d'une porte d'entrée ou autre au foyer, telles que cutanée, pleureux pulmonaire, généto-urinaire ou RL ou digestif et puis si d'autres diagnostiques, on peut aller jusqu'à la ponction viopsidisco-vertébrale qui va essayer de mettre en évidence le germe, donc les germes bannaux ou la tuberculose et l'examen histologique à la recherche de granulome épithéliologique ontocellulaire avec nécrose caséieuse qui est en faveur d'une infection tuberculeuse. Les

radiographies du rachis sont normales au début, d'où l'intérêt de l'IRM et tardivement vont apparaître un flou des plateaux vertébraux, des érosions, des géodes dites en miroir, un pèsement discal, une image de fuseau paravertébral en rapport avec un abcès du psoas et l'IRM c'est l'examen de choix permettant un diagnostic précoce en montrant des lésions en hyposignale T1, hypersignale T2 et qui se rehaussent après injection de produits de contraste.

Sur cette radiographie simple de rachis face et profil en rapport avec une tuberculose mal de pote, on voit une volumineuse macrogéode au miroir en L3-L4 avec un pèsement discal prédominant à droite. Sur cette IRM séquence pondérée en T1 après injection intraveineuse de gadolinium, on voit un hypersignal de disque intervertébral avec une prise de contraste par le gadolinium avec un abcès dans les parties molles prévertébrales et dans l'espace péri-dural en rapport avec une spondylodiscite bactérienne. Deuxième étiologie à côté des infections vertébrales, il y a la pathologie tumorale, d'abord maligne, il faut en penser chez un sujet âgé avec une altération de l'état général.

Parmi les diagnostics, il y a le myélome multiple, les métastases osseuses d'un néo-ostéophile. Par exemple, on peut avoir une image condensante en rapport avec une métastase d'un néo-duprostate, l'image lytique en rapport avec des métastases du poumon, sein, thyroïde, prostate, subdigestif et rein et mixte en rapport avec une tumeur thyroïdienne et rein. Les tumeurs primitives telles que l'infant, plasmocytome, chondrosarcome et sarcome.

Sur ces images radiographiques, on voit dans la première à gauche des métastases osseuses avec une hélice pédiculaire de L2. L'image du milieu, c'est des métastases condensantes d'un néo-de-la-prostate et puis cette image IRM, un cancer du pancréas avec des métastases osseuses rachidiennes multiples. Les tumeurs bénignes, que ce soit rachidiennes ou intra-rachidiennes, dans les étiologies rachidiennes, on cite l'ostéome ostéoïde qui est responsable de douleurs calmées par l'aspirine, visible à la scintigraphie ou bien à la TDM ou l'IRM.

Il y a aussi le quistancivrisma, les tumeurs aséligentes et autres. Les tumeurs intra-rachidiennes, le néurinome qui est responsable de douleurs nocturnes intenses et on les voit à l'IRM, comme l'image que vous voyez sur l'IRM à droite. Et autre étiologie, les pendiments.

Les pathologies rhumatismales, on cite les spondylarthropathies, c'est essentiellement un sujet jeune de sexe masculin, donc un sujet jeune qui a des lombalgies inflammatoires et qui sont associées à des signes tels que des fessalgies inflammatoires, une atteinte articulaire périphérique et ankylosante, des manifestations extra-articulaires telles qu'un psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et puis ce sont des lombalgies qui sont sensibles aux AINS. A la radiographie, on peut avoir une sacroilite bilatérale ou des syndesmophytes. Quand vous voyez sur ces radiographies, on a des syndesmophytes étagés avec formation des ponts osseux intervertébraux et même une coulée osseuse interépineuse en rapport avec une spondyloarthrite avancée.

L'achondrocasinose articulaire, c'est une pathologie qui survient essentiellement chez la femme âgée. L'étage le plus fréquemment touché étant le rachis cervical, mais une atteinte du rachis lombaire est possible. Il faut se baser sur les antécédents qui relèvent le plus souvent des crises aiguës, fluxionnaires, articulaires, périphériques, essentiellement au niveau des genoux, des épaules et des poignets.

A la radiographie, on peut trouver un liseré calcique au niveau des articulations périphériques, au niveau vertébral, des calcifications, des scales. Dans l'enquête étiologique, on peut trouver une achondrocasinose primaire ou secondaire à une hyperparathyroïde. Quant à la goutte, l'atteinte rachidienne est exceptionnelle.

Les fractures au cours d'ostéopathie fragilisante bénite. On peut avoir une ostéoporose fracturaire. Il faut penser à l'ostéoporose chez une femme âgée, ménopausée, qui se manifeste par des douleurs aiguës brutales, intenses et qui font suite à un traumatisme minime.

Ça c'est la caractéristique de la fracture osteoporotique. Telle qu'une chute de sa hauteur ou après un effort minime, il s'accompagne d'une impotence fonctionnelle majeure avec une évolution favorable en quelques mois. Sur le plan radiographique, on va avoir une diminéralisation osseuse diffuse, on va avoir une fracture de degré variable qui va du simple enfouissement du plateau jusqu'à la vertèbre ou galette complètement aplatie.

Les fractures sont souvent multiples et symétriques avec respect du mur postérieur et des pellicules, ce qui permet de les différencier des fractures vertébrales malignes. Deuxième maladie fragilisante, c'est l'ostéomalacie qui est responsable de douleurs diffuses à côté des lombalgies. Il peut y avoir aussi des méalgies et des douleurs osseuses diffuses.

La fracture est biconcave dite en aile de poisson et le diagnostic est posé par la réalisation d'huile en fousse au calcique et le dosage de la 25 OH vitamine D. Les lombalgies communes sont les plus fréquentes et sont des théologies bénies. Elles peuvent être aiguës en rapport avec l'embago par hernie discale. Elles sont de bon pronostic et la guérison est obtenue dans 90% des cas.

La lombalgie peut être chronique évoluant de plus de 3 mois en rapport avec des lésions dégénératives de différentes structures de rachis lombaires. Le diagnostic positif est essentiellement clinique et l'imagerie n'est pas systématique en l'absence de drapeaux rouges. Il y a deux situations, lombalgie aiguë avec évolution favorable et lombalgie chronique évoluant de plus de 3 mois.

Pour la lombalgie aiguë le plus souvent il s'agit d'un lombago aigu à la suite d'un soulèvement ou faux mouvement. Le malade sent un blocage rachidien qui l'empêche de bouger avec une douleur mécanique et impulsive. A l'examen on va trouver une raideur segmentaire qu'on appelle le signe de cassure avec des points douloureux et une contracture paravertébrale.

Les examens complémentaires ne sont pas systématiques comme on l'a dit à chaque fois. Moins de 50 ans si la clinique ne nous laisse aucun doute, aucun examen complémentaire n'est utile et plus au-delà de 50 ans on peut faire appel à des radiographies chez une femme ménopausée pour éliminer une fracture osteoporotique. Alors concernant l'évolution, la guérison est obtenue chez la majorité des patients moins d'une semaine.

75 à 90 % des personnes vont reprendre le travail avant un mois. La récurrence est retrouvée chez un tiers des patients, parfois plusieurs épisodes par an, qui peuvent gêner la vie quotidienne. Il faut savoir que la tolérance est liée beaucoup plus aux facteurs psychosociaux et professionnels qu'aux facteurs anatomiques et chez ces facteurs psychosociaux ne sont identifiables que dans moins de 20 % des cas.

L'identification de facteurs de risque de passage à la chronicité quand on a un emballage aigu et utile pour mettre en place des mesures de prévention ciblées. Parmi les facteurs de risque de passage à la chronicité, je cite ceux en rapport avec le travail, telles qu'une insatisfaction professionnelle, rapport avec les comportements, tels un repos prolongé, d'ailleurs en matière de l'emballage aigu, il faut raccourcir la période de repos au strict minimum, des facteurs en rapport avec les attitudes et les croyances à propos du mal de dos, tels que le catastrophisme, et puis les facteurs psychologiques quand une personne a une dépression associée, c'est un facteur de passage à la chronicité. Parmi les étiologies de la lombalgie chronique, il y a l'arthrose rachidienne qui se trouve en rapport avec des métiers au sport à risque.

On retrouve des antécédents d'un lumbago ou de sciatique chez ces patients. La douleur et les mécanismes sont non spécifiques. La radiographie permet de rattacher une lombalgie à une discarthrose en montrant les signes cardinaux de l'arthrose, à savoir le pincement discal, l'ostéocondensation des plateaux vertébraux, l'ostéophytose et la présence de vide discal, elle est possible.

Comme on voit sur ce schéma, vous avez le pincement discal, l'ostéocondensation et les ostéophytes. Sur cette radiographie du rachis lombaire de face, vous voyez les ostéophytes en latéral avec le pincement rachidien. Ici, c'est une radiographie du rachis lombaire de profil où vous voyez le pincement, l'ostéocondensation et les ostéophytes.

Deuxième étiologie, c'est l'arthrose interapophysaire postérieure qui survient chez les femmes obèses ménopausées. Ça comporte un syndrome trophostatique post-ménopausique qui regroupe une hyperlordose lombaire avec un relâchement de la sangle abdominale. Donc c'est une douleur lombaire qui se caractérise par une absence de l'impulsivité à la tête et une douleur latéralisée en hyperextension.

À la radiographie, comme vous voyez sur cette radiographie du rachis lombaire de profil, on retrouve une arthrose interapophysaire postérieure. Troisième étiologie, c'est le spondylodysthesis qui est défini par le glissement antérieur d'une vertèbre par rapport à la

vertèbre sous-jacente. Elle est secondaire à deux mécanismes, soit par une lyse ismique, et cette lyse ismique survient essentiellement chez les sujets jeunes, favorisé par certains sports comme le gymnastique, le plongeur, le judo, le saut en hauteur, et les symptômes dès l'âge jeune.

Le spondylodysthesis dégénératif survient chez les sujets âgés et est favorisé par l'arthrose interapophysaire postérieure. Comme vous voyez sur cette radiographie du rachis lombaire, avec un décalage entre les deux vertèbres adjacentes. Le canal lombaire étroit peut être congénital comme peut être acquis si le canal lombaire rétrécit, secondaire à une arthrose interapophysaire postérieure, un spondylodysthesis ou une dysarthrose.

Donc on va retrouver chez un sujet âgé une douleur qui est majorée en position debout et améliorée en position penchée en avant. Elle peut s'accompagner d'une claudication intermittente à la marche entraînant une diminution du périmètre de marche à la longue. Sur la radiographie du scanner, on va poser le diagnostic en mesurant le diamètre du canal rachidien.

Un diamètre normal est au-delà de 15 mm et inférieur à 2 mm, on parlera d'un canal lombaire rétrécit. L'arthrose interépineuse ou syndrome de bistrope est secondaire à un contact interépineux et le diagnostic est fait à la radiographie, comme vous voyez sur cette radiographie lombaire de profil. Et on peut aussi avoir d'autres étiologies, notamment les scolioses sévères et évolutives, le syndrome de men.

Le syndrome de men est secondaire à une irritation de la branche postérieure du deuxième nerf costal et que se manifeste par des douleurs projetées à la crête iliaque. Concernant le traitement, la lombalgie symptomatique va être traitée de façon spécifique à l'étiologie, donc ce sera les antibacillaires, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, la chimiothérapie, la radiothérapie, donc c'est en fonction de l'étiologie. Et puis à la lombalgie commune, elle va demander un traitement médicamenteux et non médicamenteux.

Alors concernant le traitement non médicamenteux, il faut informer et surtout rassurer le malade. Le port d'une ceinture lombaire élastique est indiqué lors des efforts. Reprise des activités quotidiennes, y compris l'activité professionnelle est indispensable, activités physiques adaptées et réadaptations fonctionnelles et activités sportives, les techniques manuelles telles que les manipulations et les mobilisations.

Concernant les traitements médicamenteux, on peut faire appel aux antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr en évaluant la balance bénéfice-risque. Les myorelaxants, ils sont controversés, mais s'ils sont donnés dans les lombalgies aiguës, ça va être pour des périodes courtes. On peut faire appel aussi aux infiltrations cortisoniques.

Quand il s'agit d'une arthrose antéapophysaire postérieure, un poussé congestif essentiellement et dont le canal lombaire est rétréci, après échec des traitements, les autres médicaments. Les indications, dans la lombalgie aiguë, la prise en charge doit être le plus minimale possible. On

fera appel aux antalgiques, aux ANS, les myorlaxants.

À ce stade, on ne fera pas de rééducation ni de manipulation. Il faut conseiller la poursuite des activités habituelles dans la maladie de douleur. La ceinture lombaire trouve sa place ici et en cas d'échec, des infiltrations cortisoniques seront possibles.

Dans la lombalgie chronique, le traitement préventif a un rôle très important, notamment l'éducation des personnes exposées, améliorer les conditions de travail, favoriser le sport, le renforcement musculaire. Il n'y a pas d'effet protecteur d'un port systématique de lombostar, donc il faut le laisser pour aider dans les phases d'aiguë. Traitement symptomatique, tels les antalgiques, on peut faire appel aux antidépresseurs quand il y a une dépression associée.

La masoquinisithérapie trouve une place importante dans la lombalgie chronique pour éviter les récives, qui va viser à faire un renforcement abdominal, un renforcement et étirement des muscles sous pile vient, il y a un verrouillage lombosacré, des programmes de réadaptation intensive, psychique et physique, qui sont nécessaires. Donc on conclut sur cet arbre décisionnel, donc devant et lombalgie aiguë, il faut chercher les signes d'alerte rouge. En leur absence, on parlera de lombalgie commune, on va proposer un traitement symptomatique.

Si nous avons une amélioration, on va prévenir les rechutes, essentiellement en se basant sur leur éducation. Quand on n'a pas d'amélioration, on va passer aux bras d'à côté. Quand on a des signes d'alerte rouge, il faut voir s'il n'y a pas de signes neurologiques.

En leur absence, on va faire des radiographies pour avoir un diagnostic certain. Si c'est le cas, on va faire un traitement étiologique avec un complément d'imagerie si nécessaire. Et en cas de non-diagnostic, si on n'a pas de diagnostic certain, on va compléter l'imagerie pour poser le diagnostic.

En présence de signes neurologiques déficitaires, c'est une urgence médico-chirurgicale, donc il faut orienter le malade vers une structure chirurgicale.